**Poder Judiciário**
**Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul**
**Vara Judicial da Comarca de Crissiumal**

Rua Vinte de Setembro, 245 - Bairro: Centro - CEP: 98640000 - Fone: (55) 3029-9956 - Balcão Virtual: (55) 9.9727-0132 - Email: frcrissiumvjud@tjrs.jus.br

**PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5001136-91.2023.8.21.0094/RS**

**AUTOR**: ELIZETE CLARICE KLEIN
**RÉU**: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
**RÉU**: MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL / RS

# SENTENÇA

**ELIZETE CLARICE KLEIN** ajuizou ação para fornecimento de medicamento com pedido de tutela de urgência incidental contra o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL / RS.**

Sustentou apresentar Asma Brônquica Grave do Tipo 2, Eosinofílica (CID J45), necessitando, em razão disso, do medicamento DUPIXENT (DUPILUMABE) 200mcg – aplicação de 2 ampolas subcutâneo em ambiente hospitalar como dose de indução; após manter a aplicação de 1 ampola de 200mcg subcutâneo a cada 14 dias como dose de manutenção, por período de 6 meses. Aduziu não possuir condições para aquisição do fármaco. Pediu liminarmente a concessão do medicamento e, ao final, procedência. Postulou a concessão da gratuidade judicial. Juntou documentos.

Deferida a gratuidade judiciária, bem como requisitado ao DMJ parecer técnico (evento 4.1).

Sobreveio Nota Técnica do medicamento (evento 11.1).

Determinada intimação do médico assistente para esclarecimentos (evento 13.1).

O médico assistente apresentou laudo complementar (evento 17.1).

Foi concedida a tutela de urgência (evento 19.1).

Citado, o Estado do Rio Grande do Sul apresentou contestação (evento 31.1). Mencionou a necessidade do cumprimento dos critérios fixados pelas teses dos Tribunais Superiores. No mérito, sustentou a aplicação do entendimento fixado pelo tema 793 do STF, sendo a competência da União o julgamento de competência no âmbito SUS. Referiu sobre a necessidade do cumprimento dos critérios fixados pelo STJ no tema repetitivo n.° 106. Discorreu sobre o alto custo do medicamento. Pugnou pela emenda à inicial pela parte autora para inclusão da União no polo passivo. Requereu a improcedência da demanda.

Citado, o Município apresentou contestação (evento 35.1). Preliminarmente arguiu sua ilegitimidade passiva, atribuindo o dever de custear o tratamento a União. Discorreu sobre o entendimento fixado pelo tema 793 do STF. No mérito requereu a improcedência dos pedidos. Informou que não poderia fornecer medicamentos de forma indiscriminada, devendo atender a população de forma igualitária, tendo em vista que teria pouca disponibilidade orçamentária. Sustentou o alto custo do medicamento pleiteado. Postulou a improcedência do pedido.

Houve réplica (evento 39.1).

Determinada a intimação das partes para dizerem sobre o interesse nas provas a produzir (evento 41.1), a parte autora informou não possuir interesse na produção de outras provas (evento 46.1), o Estado por sua vez informou não ter interesse na produção de provas (evento 48.1), já o Município renunciou com ciência ao prazo (evento 50).

A autora requereu o bloqueio de valores (evento 52.1)

Foi deferido o pedido (evento 56.1).

Vieram os autos conclusos para sentença.

**Decido.**

**1. Preliminar: legitimidade passiva.**

Em se tratando de direito à saúde, o Supremo Tribunal Federal entendeu inicialmente que a responsabilidade solidária dos entes federativos, quanto ao fornecimento de medicamentos, autorizava o requerente a pleiteá-los de qualquer um dos entes federativos – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios - isolada ou conjuntamente (ARE 738729 AgR, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 25/06/2013, DJe-159 DIVULG 14-08-2013 PUBLIC 15-08-2013).

Ao revisitar a questão em sede de ED no RE n.º 855.178/SE (Tema 793 de repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal deu nova interpretação ao alcance da solidariedade dos entes federativos: *"o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente" significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma*

*prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas"* (RE 855178 ED, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020).

Ou seja, quando o exame postulado judicialmente integrar as listas do SUS, a demanda pode ser proposta contra qualquer dos entes federativos, isolada ou cumulativamente.

Portanto, afasto a preliminar suscitada.

**2. Mérito.**

Conforme o relato da inicial, a autora, ELIZETE CLARICE KLEIN, apresenta Asma Brônquica Grave DO Tipo 2, Eosinofílica (CID J45), necessitando, em razão disso, do medicamento DUPIXENT (DUPILUMABE) 200mcg – aplicação de 2 ampolas subcutâneo em ambiente hospitalar como dose de indução; após manter a aplicação de 1 ampola de 200mcg subcutâneo a cada 14 dias como dose de manutenção, por período de 6 meses. Aduziu não possuir condições para tanto.

A pretensão da parte requerente, então, cinge-se à obrigação de fazer, consistente no fornecimento do medicamento pelo Estado e Município de Crissiumal.

O artigo 196, *caput* e § 1º da Constituição Federal de 1988 estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, atividade cujo financiamento cabe à União, aos Estados e aos Municípios.

Ainda, a União, Estados, Distrito Federal e Municípios são solidariamente responsáveis pelo atendimento integral à saúde dos cidadãos. Desta forma, a responsabilidade dos entes públicos para o atendimento à saúde é ampla.

Já o artigo 242 da Constituição do Rio Grande do Sul preceitua que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada do Sistema Único de Saúde no âmbito do Estado.

A Lei do SUS (Lei n.º 8.080/90), por sua vez, dispõe que estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a assistência terapêutica integral, inclusive farmacêutica, mediante a dispensação de medicamentos e produtos de interesse para a saúde, cuja prescrição corresponda as diretrizes terapêuticas definidas em protocolo clínico (artigo 6º, inciso I, "d" e artigo 19'M, inciso I).

Com relação aos medicamentos não incluídos em protocolos clínicos do SUS, o Superior Tribunal de Justiça, ao decidir o tema 106 de recurso repetitivo (EDcl no REsp1657156 RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em12/09/2018, DJe 21/09/2018), entendeu o tema da seguinte forma:

A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos:

**i)** Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

**ii)** incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

**iii)** existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.

Pois bem.

No caso concreto, encontram-se acostados exames e laudos médicos que comprovam a necessidade do tratamento, seus benefícios e a inviabilidade de substituição (evento 1, LAUDO5 e evento 17, LAUDO1):

**Elizete Clarice Klein**

Laudo médico:

O paciente Elisete Clarice Klein, 49 anos, encontra-se sob meus cuidados há cerca de 6 anos, com diagnóstico de asma brônquica grave do tipo T2, eosinofílica ( cid J 45) (exames em anexo), com inúmeras exacerbações ao longo dos últimos anos, incluindo internações hospitalares frequentes e inúmeras idas ao serviços de pronto atendimento. Somando-se a isso necessitou uso de corticoterapia sistêmica repetidas vezes ao ano (mais de 3 x x ao ano) e apresenta mal controle da doença a despeito de medicações inaladas em doses plenas. Hemograma datado de 17.10.2022 com 636 eosinófilos ou 8%.

A mesma preenche critérios para asma grave segundo a diretriz da Sociedade Européia (ERS) e Sociedade Torácica Americana (ATS) de 2020 (referência 1), e segundo a diretriz da sociedade Brasileira de pneumologia e tisiologia (referência 2) permanecendo com doença não controlada e função pulmonar alterada conforme comprovado por exames e avaliação clínica (anexo).

Ressalto que o mesmo faz uso atual de corticoesteróide sistêmico repetidas vezes ao ano (mais de 4 vezes ao ano) , corticoesteróide inalado em alta dose(beclometasona 800 mcg 2 x dia ou equivalente) e broncodilatador de longa duração beta adrenérgico ( formoterol 12 mcg 2 x dia), broncodilatador de longa duração muscarínico (brometo de tiotrápio 2,5 mcg 2 jatos ao dia), broncodilatadores de curta duração inalados. Fez uso de Nucala (mepolizumabe) por 6 meses sem resposta esperada (sem redução de sintomas, ou de exacerbações, permanecendo com sintomas diários e limitantes), e não preenche critérios para uso de omalizumabe disponível no SUS .

A diretriz Gina (referência 3) preconiza o uso de terapia complementar com o medicamento Dupilumabe (Dupixent) no step/passo 5, para pacientes com asma predominantemente caracterizada por inflamação tipo 2 não controlada, mesmo com uso de medicações inaladas em altas doses e/ou corticoterapia sistêmica , como no caso em questão. Ou pacientes em uso de corticoide sistêmico independente de marcadores inflamatórios.

A terapia imunobiológica com o medicamento Dupilumabe (Dupixent) inibe a ação da IL 4 e IL 13. Tal ação se traduz em redução do número de exacerbações da doença, redução da necessidade de consultas em serviços de emergência e internações hospitalares e melhora a função pulmonar conforme o Estudo QUEST (referências 4 ). Ao mesmo tempo, o dupilumabe proporciona uma redução significativa do uso de corticoterapia sistêmica neste grupo de pacientes conforme o estudo VENTURE (referência 5).

Solicito uso de terapia complementar com dupilumabe (dupixent): Ampola 200 mg, sendo utilizada dose de indução de 2 ampolas inicialmente e após esta, 1 ampola de 200 mg a cada 14 dias para uso contínuo.

Ressalto que tal terapia é aprovada por órgão regulador ANVISA, não tratando-se de medicamento experimental e que não há a disposição no SUS em nível municipal, estadual ou federal.

Três Passos 02.06.2023

Claudio Figueiredo
Pneumologista
CRM: 35.299


1. Management of Severe asthma a European Respiratory Society/ American Thoracic Society guideline. European Respiratory Journal , jan 2020.
2. Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Recomendações para o manejo da asma brônquica, 2020. Jornal Brasileiro de Pneumologia.
3. Gina (Global initiative for asthma) 2019 : a fundamental change in asthma management. Eur Respir J 2019; 53: 1901046..
4. QUEST. Dupilumab efficacy and safety in moderate-to severe uncontrolled asthma. NEjm, 2018: 378: 2486-2496.
5. VENTURE. Efficacy and safety of Dupilumab in Glucocorticoid-dependent severe asthma , NEjm, 2018, 378: 2475-2485.

**Paciente: Elizete Maria Klein**

**Em resposta ao ofício Procedimento Comum Cível N: 5001136-91.2023.8.21.0094/RS**

Informo que a paciente acima citada apresenta asma grave do tipo eosinofílico, acompanho a mesma há vários anos e a mesma já realizou todos os tratamentos possíveis e disponíveis no sistema único de saúde.

A mesma já utilizou as medicações inalatórias em doses máximas, permanecendo com inúmeras exacerbações (crises) nos últimos anos, com necessidade de uso de corticoterapia repetidas vezes (somando-se a isso apresenta tosse e falta de ar diariamente, o que a impossibilita de realizar atividades laborais e da vida diária, se declara agricultora).

Em pacientes com tal gravidade (Step 5 GINA) a diretriz da Sociedade Braileira de Pneumologia em asma grave e a recomendação GINA (Global initiative for asthma ) preconizam o uso de medicamentos imunobiológicos (os quais reduzem crises/exacerbações, melhoram sintomas e melhoram função pulmonar) em associação com demais medicações (dos steps anteriores 4)

Existem 5 medicamentos imunobiológicos aprovados para este fim no Brasil:

1.**Mepolizumabe** (Nucala, inibidor da IL 5)( disponível no SUS): Paciente fez uso deste fármaco por 6 meses, sem melhora alguma e com mal estar e reações adversas após aplicação, reavaliei a mesma após este período e a mesma não apresentou a resposta esperada.

2.**Omalizumabe** (Xolair, anti IGE) (disponível no SUS) : indicado para pacientes com asma de cunho alérgico grave (a paciente em questão apresentou ao londo dos anos IGE sérica total de 28 a 56 UL/ml e suas IGES específicas foram negativas para os antígenos investigados, não sendo a paciente candidata ao uso deste fármaco).

3.**Benralizumabe** (fasenra, inibidor do receptor da IL 5) : Fármaco não disponível no SUS com mecanismo de ação semelhante ao mepolizumabe , ao qual a mesma não respondeu.(inibidor do receptor da IL 5)

4.**Dupilumabe** (dupixent): (não disponível no SUS) medicamento imunobiológico com ação em asma Th2 (perfil alérgico e eosinofílico) seria uma opção para paciente acima citada com falha ao medicamento mepolizumabe, solicito o medicamento para uso por 6 meses, período após o qual, a mesma será reavaliada e a necessidade de continuação (ou não) do fármaco revista.

5.**Tezepilumabe** (Tezspire) : tal medicamento não estava disponível para comercialização no Brasil na época da elaboração deste laudo (não disponível no SUS ).

Ressalto que a mesma fez investigação extensa nos últimos anos para exclusaão de outras patologias que pudessem estar agravando seu caso (realizou tomografia de tórax e broncoscopia e avaliação de doenças de via aérea superior ).

Obs: As referências acima citadas encontram-se discriminadas em laudo anexo e enumeradas no mesmo.

Desde já a disposição

Três Passos 04 de julho de 2023

Claudius Figueiredo
Pneumologista
CRM: 25 299

**Claudius Figueiredo**

**Pneumologista CRM 25299**

Além disso, conforme pesquisa à Nota Técnica emitida pelo DMJ referente ao medicamento pleiteado, a conclusão foi favorável ao fornecimento do medicamento DUPILUMABE, conforme segue:

**Conclusão**

**Tecnologia:** DUPILUMABE

**Conclusão Justificada:** Favorável

**Conclusão:** Considerando a refratariedade dos sintomas, tentativa de utiização de todas as alternativas disponíveis pelo SUS e a necessidade de uso crônico de corticóide oral, conforme atestado no laudo médico acostado;
Conclui-se que há elementos técnicos que permitem sustentar parecer favorável à demanda apresentada.
Entretanto é necessário que o caso em tela seja reavaliado quanto à resposta à terapia, visto que o medicamento deverá ser descontinuiado caso não tenha havido melhora clínica após 4 meses de tratamento.

**Há evidências científicas?** Sim

**Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM?** Sim

**Justificativa:** Com risco de lesão de órgão ou comprometimento de função

Assim, para fins de garantir uma melhor qualidade de vida à autora, deve a pretensão ser acolhida, especialmente porque comprovada a hipossuficiência econômica e a necessidade do medicamento, como já havia sido reconhecido por ocasião da decisão que deferiu a tutela de urgência (evento 19, DESPADEC1).

E, com relação ao medicamento específico postulado na petição inicial, transcrevo decisões do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul reconhecendo ser devido o seu fornecimento:

> *DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DUPILUMABE 300 MG. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. ITEM 5.2 DA TPI NO RE Nº 1.366.243-SC (TEMA 1.234). 1. Na casuística, a parte beneficiária postula a dispensação do medicamento Dupilumabe 300mg, na forma do laudo médico carreado, por ser portadora de dermatite atópica (CID10 L20), fármaco não elencado nas listas do SUS.2. A par dos parâmetros estabelecidos pelo Pretório Excelso na TPI no RE nº 1.366.243-SC, considerando que se lida com demanda que envolve o fornecimento de tratamento que não integra as listas do SUS, compulsória a incidência do item 5.2 na espécie, prevalecendo a jurisdição do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar, no caso, o Estado do Rio Grande do Sul e, por consequência, a competência é desta Justiça Estadual.3. Outrossim, existe laudo fundamentado do médico assistente, no qual consta que a medicação prescrita é a mais indicada para o tratamento da enfermidade do autor, não havendo outro tratamento fornecido pelo SUS que possa ser utilizado com a mesma*

*eficácia. Além disso, a hipossuficiência está comprovada, pois foi deferido ao demandante o benefício da gratuidade da justiça. Por fim, o fármaco postulado possui registro na ANVISA, razões pelas quais não há óbice legal ao seu fornecimento. Critérios estabelecidos no Tema 106 da Corte Superior.4. Aplicação ao caso do entendimento materializado no verbete nº 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. Prestígio ao art. 927, III, do CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA. (Apelação Cível, Nº 50226789020228210001, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antonio Monteiro Pacheco, Julgado em: 03-06-2024);*

*DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. DUPILUMABE 300 MG. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. ITEM 5.2 DA TPI NO RE Nº 1.366.243-SC (TEMA 1.234). NOTA TÉCNICA NATJUS. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS PARTICULARIDADES DE CADA PACIENTE. REQUISITOS DO TEMA Nº 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CONTEMPLADOS. 1. Na casuística, a parte beneficiária postula a dispensação do medicamento Dupilumabe 300 mg, na forma do laudo médico carreado, por ser portadora de dermatite atópica (CID10 L20), fármaco não elencado nas listas do SUS.2. A par dos parâmetros estabelecidos pelo Pretório Excelso na TPI no RE nº 1.366.243-SC, considerando que se lida com demanda que envolve o fornecimento de tratamento que não integra as listas do SUS, compulsória a incidência do item 5.2 na espécie, prevalecendo a jurisdição do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar, no caso, o Estado do Rio Grande do Sul e, por consequência, a competência é desta Justiça Estadual.3. Outrossim, existe laudo fundamentado do médico assistente, no qual consta que a medicação prescrita é a mais indicada para o tratamento da enfermidade do autor, não havendo outro tratamento fornecido pelo SUS que possa ser utilizado com a mesma eficácia. Além disso, a hipossuficiência está comprovada, pois foi deferido ao demandante o benefício da gratuidade da justiça. Por fim, o fármaco postulado possui registro na ANVISA, razões pelas quais não há óbice legal ao seu fornecimento. Critérios estabelecidos no Tema 106 da Corte Superior.4. Malgrado o conteúdo da Nota Técnica NatJus, o atestado médico firmado por profissional devidamente habilitado, que acompanha o paciente de forma individualizada, constitui prova suficiente para embasar a pretensão da parte autora.5. Aplicação ao caso do entendimento materializado no verbete nº 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e no art. 206, XXXVI, do RITJRS. Prestígio ao art. 927, III, do CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA.(Apelação Cível, Nº 50265802220218210022, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Nelson Antonio Monteiro Pacheco, Julgado em: 03-06-2024).*

Portanto, a procedência do pedido é medida impositiva.

Com relação aos honorários advocatícios, cumpre referir que o Superior Tribunal de Justiça cancelou a súmula 421, que vedava a condenação em honorários em favor da Defensoria Pública quando atuasse contra o próprio ente que faz parte, o que foi feito em razão do julgamento do tema 1002 de repercussão geral (é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra).

Ante o exposto, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ratifico a antecipação de tutela concedida e **julgo procedente** o pedido formulado por ELIZETE CLARICE KLEIN em face do ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL e MUNICÍPIO DE CRISSIUMAL para condenar os réus a fornecerem, solidariamente, em favor da autora, o medicamento Dupilumabe 200mcg (2 ampolas subcutâneas como dose de indução e, após, 1 ampola subcutânea a cada 14 dias, como dose de manutenção, pelo período inicial de 6 meses, conforme receituário médico).

Sem condenação em custas processuais, tendo em vista que os réus são isentos (artigo 5º, incisos I da Lei Estadual n.º 14.634/2014).

Condeno os réus ao pagamento de honorários advocatícios em favor do FADEP, na importância de 10% sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Interposta(s) apelação(ões), intime(m)-se o(s) apelado(s) para contrarrazões, no prazo legal. Caso interposta apelação adesiva pelo apelado, intime-se o apelante para contrarrazões, no prazo legal.

Após, apresentadas ou não as contrarrazões, remetam-se os autos ao TJRS, conforme o artigo 1.010 do CPC.

Sentença publicada e registrada eletronicamente. Intimem-se

Recolhidas as custas/despesas processuais e/ou cumprido o disposto no Ato n.º 072/2022-P, baixe-se.

---

Documento assinado eletronicamente por **TATIANE LEVANDOWSKI, Juíza de Direito**, em 20/6/2024, às 19:53:7, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10060974478v6** e o código CRC **515630b6**.

---